ÉTUDE POLYGRAPHIQUE DU SOMMEIL

Dr. Selma BAKHA

Pneumologue - Allergologue

N° Ordre : 0535/24

0796 222 597 / 0663 755 584

Cité 19 Juin, derrière l'hôpital Hakim Okbi
en face des urgences, Guelma

selma.bakha@hotmail.com

INFORMATIONS PATIENT

Nom :	Mahboub Karima	**ID Patient :**	20260401-101
Genre :	Femme	**Durée enreg. :**	519 min
Âge :	49	**Taille (cm) :**	170
Poids (kg) :	74	**IMC :**	25,6 (Surpoids)

Dr Bakha

1. GRAPHIQUE DE TENDANCE

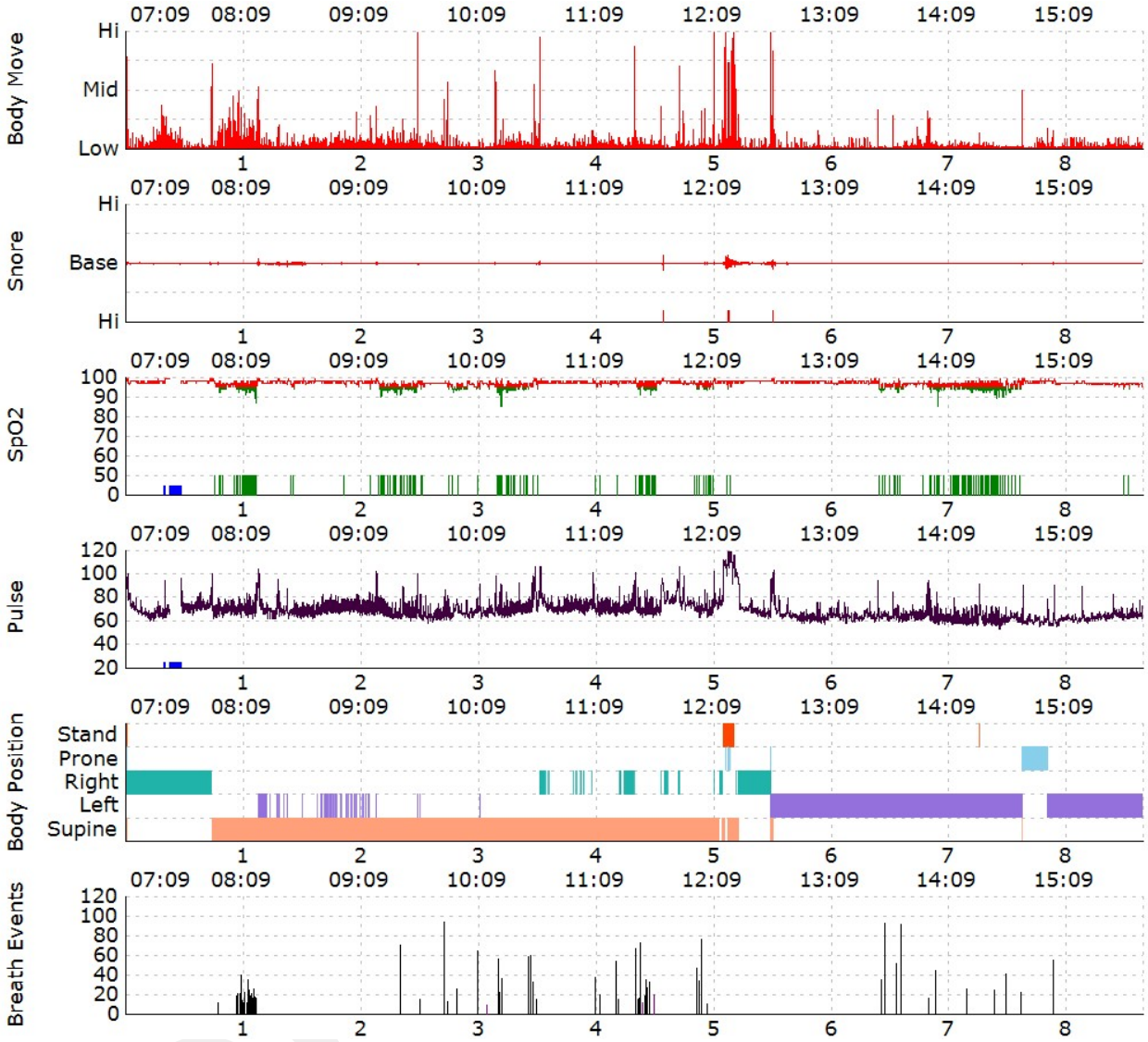

FIGURE 1 – **Analyse temporelle des données polygraphiques.**

2. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS

2.1. POSITIONS DU CORPS

Table 1 – **Analyse des positions du corps et événements associés**

Position	Durée (min)	% Durée	HYPO	SAOS	AC	AM	DO	Tot. Év.
Dorsale (SUP)	257,4	49,6	47	3	0	0	96	146
Ventrale (PRO)	13,4	2,6	0	0	0	0	0	0
Côté gauche (LAT-G)	180,0	34,7	11	0	0	0	59	70
Côté droit (LAT-D)	64,9	12,5	0	0	0	0	0	0
Debout	3,4	0,7	0	0	0	0	2	2

2.2. ÉVÉNEMENTS SpO_2

Table 2 – **Analyse des événements de saturation en oxygène (SpO_2)**

Paramètre SpO_2	Valeur	Référence
SpO_2 max (%)	99	95 – 100 %
SpO_2 min (%)	**85**	$\geq$ 90 %
SpO_2 moy (%)	97	$\geq$ 95 %
Durée DO (min)	88,6	—
IDO (/h)	**19,6**	$<$ 5 /h
Nombre DO	157	—
Durée $<$ 95% (min)	50,6	—
% $<$ 95%	9,9	$<$ 10 %
Durée $<$ 90% (min)	0,8	—
% $<$ 90%	0,2	$<$ 1 %
Durée $<$ 85% (min)	0,0	0 %
% $<$ 85%	0,0	0 %

2.3. INFORMATIONS DU POULS

Table 3 – **Informations sur les mesures du pouls**

Paramètre Pouls	Valeur (bpm)
FC max	124
FC min	53
FC moy	69,1

Dr. Bakha

2.4. ÉVÉNEMENTS RESPIRATOIRES (AP & HYPO)

Table 4 – **Analyse détaillée des événements respiratoires**

Paramètre Respiratoire	Valeur	Indice (/h)
Apnées (AP)		
Nombre total	3	
Durée totale (min)	0,7	
Durée moy (sec)	14,1	
Hypopnées (HYPO)		
Nombre total	58	
Durée totale (min)	34,2	
Durée moy (sec)	35,4	
Total Événements Respiratoires (TER)		
Nombre total (AP + HYPO)	61	—
Durée totale (min)	34,9	—
IAH	—	**7,1**
IDO	—	19,6
IMR (RDI)	—	7,1

3. RÉSUMÉ DES INFORMATIONS CLÉS

Table 5 – **Résumé des informations principales de l'étude**

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
SpO_2 moy (%)	97	SpO_2 min (%)	**85**
IDO (/h)	19,6	Nombre SAOS	3
Nombre AC	0	Nombre AM	0
IA (/h)	0,3	Nombre HYPO	58
IH (/h)	6,7	**IAH (/h)**	**7,1**
IMR (/h)	7,1	Index Ronflements (/h)	0,5
FC moy (bpm)	69,1	Nb changements pos.	648

4. AVIS MÉDICAL

4.1. Interprétation des Résultats

L'enregistrement polygraphique, d'une excellente durée validée (519 minutes), présente les caractéristiques suivantes :

— **Syndrome d'Apnées-Hypopnées du Sommeil (SAHS) :** L'Index d'Apnées-Hypopnées (IAH) global est de **7,1 événements/heure**, ce qui définit un syndrome d'apnées du sommeil de degré **léger** ($5 \leq \text{IAH} < 15$).

— **Profil des événements respiratoires :** On note une très nette prédominance d'hypopnées (58 événements) par rapport aux apnées (seulement 3 apnées de type obstructif). La durée moyenne des hypopnées est prolongée (35,4 secondes). On ne relève aucune apnée centrale.

— **Impact de la Position :** Le syndrome présente un net caractère **positionnel**. Les événements surviennent majoritairement en position dorsale (146 événements au total), justifiant l'importance de cette position dans la survenue des troubles respiratoires.

— **Impact Oxymétrique :** La saturation moyenne de base est bien conservée à 97%. Néanmoins, l'Index de Désaturation en Oxygène (IDO) calculé à **19,6/h** est supérieur à l'IAH. On observe des épisodes de désaturation atteignant un minimum de **85%**.

— **Agitation et Sommeil :** Le tracé montre un nombre très important de changements de position (648), suggérant un sommeil fragmenté ou agité. L'index de ronflements est quant à lui très faible (0,5/h).

4.2. Conclusion Diagnostique

Le tracé est en faveur d'un **syndrome d'apnées-hypopnées du sommeil léger**, de nature **positionnelle** (aggravation nette en décubitus dorsal), avec une prédominance d'hypopnées et associé à un sommeil potentiellement fragmenté.

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

— **Diagnostic :** SAOS léger positionnel.
— **Mesures Hygiéno-Diététiques :** Prise en charge du léger surpoids (IMC : 25,6).
— **Thérapie de première intention : Thérapie positionnelle** recommandée (éviter le sommeil en décubitus dorsal) pour réduire drastiquement l'index d'événements.

Dr. Selma BAKHA
Pneumologue - Allergologue
N° Ordre : 0535/24

Bakha